INSTITUT FÜR SINNZENTRIERTE PSYCHOLOGIE

Zeitschrift für *Sinnzentrierte* Psychologie

Jahrgang 1 · Heft 1 · April 2026 · Deutsche Ausgabe

Logotherapie im Kontext der Psychotherapieforschung

Logotherapie · Existenzpsychologie · Psychotherapieforschung

S. 1–17 · Open Access

Inhalt

Heft 1/2026 · Schwerpunkt: Logotherapie im Kontext der Psychotherapieforschung · Seitenzahlen der englischen Originalfassung

EDITORIAL

Sinn als Gegenstand wissenschaftlicher Psychologie 1

Zum Auftakt der Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie

Eleanor M. Whitcombe, Sora Pazer und Samuel R. Ashford

ÜBERSICHTSARBEIT

Logotherapie und die Evidenzfrage 3

Ein narrativer Review zu Forschungsstand, methodischen Herausforderungen und Perspektiven

Samuel R. Ashford, Sora Pazer und Eleanor M. Whitcombe

THEORETISCHER BEITRAG

Lebenssinn als transdiagnostischer Faktor 7

Begriffliche Klärungen, theoretische Modelle und offene Fragen

Eleanor M. Whitcombe, Samuel R. Ashford und Sora Pazer

THEORETISCHER BEITRAG

Paradoxe Intention und moderne Expositionsverfahren 11

Ein theoretischer Vergleich von Wirkannahmen, Vorgehen und Grenzen

Samuel R. Ashford, Eleanor M. Whitcombe und Sora Pazer

METHODENBEITRAG

Die Messung von Lebenssinn 14

Purpose in Life Test, Meaning in Life Questionnaire und LeBe/SoMe im konzeptuellen und methodischen Vergleich

Samuel R. Ashford, Sora Pazer und Eleanor M. Whitcombe

Herausgeber
Institut für Sinnzentrierte Psychologie

Erscheinungsweise
halbjährlich, im April und Oktober, dazu Themenhefte

Begutachtung
Redaktionelle Prüfung und doppelt verblindetes Gutachterverfahren

Lizenz und Einsatz von KI
Alle Beiträge erscheinen im offenen Zugang unter CC BY 4.0. Sie wurden mit Unterstützung generativer KI verfasst und von den Autorinnen und Autoren geprüft. Originalsprache ist Englisch; die deutsche Ausgabe ist eine Übersetzung.

Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie
HERAUSGEGEBEN VOM INSTITUT FÜR SINNZENTRIERTE PSYCHOLOGIE

Jahrgang 1 · Heft 1 · April 2026
S. 1–2 (Original) · Open Access · CC BY 4.0
DOI 10.5281/zenodo.23319659

EDITORIAL

Sinn als Gegenstand wissenschaftlicher Psychologie

Zum Auftakt der Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie

Eleanor M. Whitcombe, Sora Pazer und Samuel R. Ashford
Institut für Sinnzentrierte Psychologie

Deutsche Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Originalfassung.

ZUSAMMENFASSUNG

Mit dem vorliegenden Heft erscheint die erste Ausgabe der Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie (ZSP). Das Editorial erläutert das Selbstverständnis der Zeitschrift, die sich als wissenschaftliches Forum für die Auseinandersetzung mit Lebenssinn, Werten und existenziellen Fragen in Psychologie und Psychotherapie versteht. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass die von Viktor E. Frankl begründete Logotherapie und die gegenwärtige empirische Sinnforschung bislang häufig nebeneinander statt miteinander gearbeitet haben. Die ZSP möchte diese Traditionen in ein kritisches Gespräch bringen, ohne einer einzelnen therapeutischen Schule verpflichtet zu sein. Das Editorial stellt den Schwerpunkt des ersten Heftes vor, der Logotherapie im Kontext der Psychotherapieforschung verortet: eine Übersichtsarbeit zur Evidenzfrage, einen theoretischen Beitrag zu Lebenssinn als transdiagnostischem Faktor, einen Vergleich der paradoxen Intention mit modernen Expositionsverfahren sowie einen Methodenbeitrag zur Erfassung von Lebenssinn. Abschließend werden die redaktionellen Grundsätze der Zeitschrift dargelegt, insbesondere die zurückhaltende und quellengetreue Wiedergabe empirischer Befunde, die klare Unterscheidung zwischen anthropologischen Setzungen und empirisch prüfbaren Aussagen sowie die Orientierung an den Zitationsrichtlinien der American Psychological Association.

Schlüsselwörter: Lebenssinn · Logotherapie · Psychotherapieforschung · Editorial · Wissenschaftsverständnis

ABSTRACT

This issue marks the launch of the Journal of Meaning-Centered Psychology. The editorial outlines the journal's aims as a scholarly forum for the study of meaning in life, values, and existential concerns in psychology and psychotherapy. It starts from the observation that logotherapy, founded by Viktor E. Frankl, and contemporary empirical research on meaning have often developed in parallel rather than in dialogue. The journal seeks to bring these traditions into critical conversation without committing itself to any single therapeutic school. The editorial introduces the thematic focus of the first issue, which situates logotherapy within psychotherapy research: a review on the question of evidence, a theoretical paper on meaning in life as a transdiagnostic factor, a comparison of paradoxical intention with contemporary exposure-based treatments, and a methodological paper on the assessment of meaning in life. Finally, it sets out the journal's editorial principles, including a cautious and source-faithful reporting of empirical findings, a clear distinction between anthropological assumptions and empirically testable claims, and adherence to the citation guidelines of the American Psychological Association.

Keywords: meaning in life · logotherapy · psychotherapy research · editorial · philosophy of science

Anliegen der Zeitschrift

Die Frage nach dem Sinn des eigenen Lebens gehört zu den ältesten Themen menschlicher Selbstreflexion. Als Gegenstand der wissenschaftlichen Psychologie hat sie jedoch lange eine randständige Rolle gespielt. Viktor E. Frankl hat mit der Logotherapie bereits um die Mitte des 20. Jahrhunderts einen psychotherapeutischen Ansatz vorgelegt, der das Streben nach Sinn als grundlegende menschliche Motivation begreift (Frankl, 1946). In den vergangenen beiden Jahrzehnten hat sich die empirische Sinnforschung zu einem eigenständigen Forschungsfeld entwickelt, das begriffliche Differenzierungen – etwa zwischen Kohärenz, Zielorientierung und Bedeutsamkeit (Martela & Steger, 2016) – ebenso umfasst wie die Frage, wie verbreitet das Erleben von Sinn im Alltag tatsächlich ist (Heintzelman & King, 2014).

Die Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie möchte diese Entwicklungen aufgreifen und ein Forum für eine wissenschaftlich anspruchsvolle Auseinandersetzung bieten. Sie versteht sich weder als Organ einer einzelnen Schule noch als Ort unkritischer Traditionspflege. Ihr Anliegen ist es vielmehr, die anthropologischen und klinischen Einsichten der Logotherapie und Existenzanalyse mit dem Methodenbewusstsein und den Befunden der gegenwärtigen Psychotherapieforschung ins Gespräch zu bringen. Dazu gehört die Bereitschaft, liebgewordene Annahmen der eigenen Tradition ebenso kritisch zu prüfen wie verkürzende Operationalisierungen eines komplexen Phänomens.

Dass Sinn ein legitimer Gegenstand empirischer Forschung sein kann, war keineswegs immer selbstverständlich. Lange Zeit galt die Frage nach dem Sinn als zu vage, zu weltanschaulich aufgeladen oder zu sehr der Philosophie zugehörig, um psychologisch untersucht zu werden. Die Entwicklung reliabler Messinstrumente und differenzierter theoretischer Modelle hat diese Einschätzung verändert. Zugleich besteht die Gefahr, das Phänomen auf das zu reduzieren, was sich leicht messen lässt. Eine Zeitschrift, die sich dem Sinn widmet, muss daher beides leisten: methodische Strenge und Offenheit für die phänomenologische Vielschichtigkeit ihres Gegenstandes.

Zum Schwerpunkt dieses Heftes

Das erste Heft steht unter dem Schwerpunkt „Logotherapie im Kontext der Psychotherapieforschung“. Die Übersichtsarbeit des Arbeitsbereichs Psychotherapieforschung fragt nach dem Stand der Evidenz für logotherapeutische und sinnzentrierte Interventionen und zeigt, dass die Antwort wesentlich davon abhängt, welches Verständnis von Evidenz zugrunde gelegt wird (Vos et al., 2015; Wampold & Imel, 2015). Ein theoretischer Beitrag diskutiert, inwieweit Lebenssinn als transdiagnostischer Faktor verstanden werden kann. Ein weiterer Beitrag vergleicht die paradoxe Intention mit gegenwärtigen Expositionsverfahren und arbeitet Gemeinsamkeiten wie Unterschiede in den angenommenen Wirkmechanismen heraus. Den Abschluss bildet ein Methodenbeitrag zu etablierten Verfahren der Erfassung von Lebenssinn, der Stärken und Grenzen der verfügbaren Instrumente vergleichend darstellt.

Gemeinsam ist den Beiträgen ein Bemühen um begriffliche Klarheit. Gerade ein Konstrukt wie „Sinn“, das in Alltagssprache, Philosophie und Psychologie in unterschiedlicher Weise verwendet wird, verlangt nach sorgfältiger Präzisierung, bevor es angemessen gemessen, untersucht oder therapeutisch adressiert werden kann.

Redaktionelle Grundsätze

Die ZSP veröffentlicht theoretische Beiträge, Übersichtsarbeiten, Methodenbeiträge, Beiträge aus Praxis und Lehre sowie Rezensionen. Die Redaktion legt Wert darauf, dass empirische Befunde zurückhaltend und quellengetreu wiedergegeben, Grenzen der Evidenz offen benannt und anthropologische Setzungen von empirisch prüfbaren Aussagen unterschieden werden. Didaktische Fallbeispiele werden ausdrücklich als konstruierte Lehrvignetten gekennzeichnet. Die Zitation folgt den Richtlinien der American Psychological Association (2020).

Wir danken allen Arbeitsbereichen des Instituts, die zum Gelingen dieses ersten Heftes beigetragen haben, und laden die Leserinnen und Leser herzlich ein, die Diskussion kritisch zu begleiten.

Literatur

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.).

Frankl, V. E. (1946). Ärztliche Seelsorge. Deuticke.

Heintzelman, S. J., & King, L. A. (2014). Life is pretty meaningful. American Psychologist, 69(6), 561–574.

Martela, F., & Steger, M. F. (2016). The three meanings of meaning in life: Distinguishing coherence, purpose, and significance. The Journal of Positive Psychology, 11(5), 531–545.

Vos, J., Craig, M., & Cooper, M. (2015). Existential therapies: A meta-analysis of their effects on psychological outcomes. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(1), 115–128.

Wampold, B. E., & Imel, Z. E. (2015). The great psychotherapy debate: The evidence for what makes psychotherapy work (2nd ed.). Routledge.

ZITIERVORSCHLAG (ORIGINALFASSUNG)

Whitcombe, E. M., Pazer, S., & Ashford, S. R. (2026). Meaning as a Subject of Scientific Psychology: On the Launch of the Journal of Meaning-Centered Psychology. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(1), 1–2. https://doi.org/10.5281/zenodo.23319659

LIZENZ, KORRESPONDENZ UND EINSATZ VON KI

Erscheint im offenen Zugang unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Korrespondenz: Redaktion der Zeitschrift. Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung generativer KI verfasst und von den Autorinnen und Autoren geprüft, die die volle Verantwortung für den Inhalt tragen.

Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie
HERAUSGEGEBEN VOM INSTITUT FÜR SINNZENTRIERTE PSYCHOLOGIE

Jahrgang 1 · Heft 1 · April 2026
S. 3–6 (Original) · Open Access · CC BY 4.0
DOI 10.5281/zenodo.23319975

ÜBERSICHTSARBEIT

Logotherapie und die Evidenzfrage

Ein narrativer Review zu Forschungsstand, methodischen Herausforderungen und Perspektiven

Samuel R. Ashford, Sora Pazer und Eleanor M. Whitcombe
Institut für Sinnzentrierte Psychologie

Deutsche Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Originalfassung.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Logotherapie gehört zu den traditionsreichsten psychotherapeutischen Ansätzen des 20. Jahrhunderts, wird in der gegenwärtigen evidenzbasierten Psychotherapie jedoch selten als eigenständiges Verfahren wahrgenommen. Der vorliegende narrative Review geht der Frage nach, wie sich der empirische Forschungsstand zu logotherapeutischen und sinnzentrierten Interventionen beschreiben lässt und welche methodischen Gründe für die vergleichsweise schmale Evidenzbasis verantwortlich sind. Zunächst wird herausgearbeitet, dass die Logotherapie sowohl eine anthropologische Grundposition als auch ein Bündel spezifischer Techniken umfasst, was die Operationalisierung als prüfbares Behandlungsprogramm erschwert. Anschließend werden zentrale Befundlinien zusammengefasst: die umfangreiche, überwiegend korrelative Forschung mit Sinnfragebögen, die meta-analytische Integration existenzieller Therapien sowie randomisiert-kontrollierte Studien zu manualisierten sinnzentrierten Programmen in der Psychoonkologie. Die Befunde sprechen insgesamt für günstige Effekte strukturierter sinnzentrierter Interventionen, sind jedoch hinsichtlich Zielgruppen, Vergleichsbedingungen und Generalisierbarkeit begrenzt. Diskutiert werden schließlich die Spannungen zwischen dem Paradigma störungsspezifischer Wirksamkeitsnachweise und dem Kontextmodell der Psychotherapie sowie die Chancen einer prozessorientierten Forschung, die nach Wirkmechanismen statt nach Schulzugehörigkeit fragt. Der Beitrag plädiert für eine Forschungsagenda, die anthropologische Grundannahmen respektiert und zugleich methodisch anschlussfähig bleibt.

Schlüsselwörter: Logotherapie · Evidenzbasierte Psychotherapie · Sinnzentrierte Psychotherapie · Psychotherapieforschung · Narrativer Review

ABSTRACT

Logotherapy is one of the most established psychotherapeutic approaches of the twentieth century, yet it is rarely recognized as a distinct treatment within contemporary evidence-based psychotherapy. This narrative review examines how the current state of empirical research on logotherapeutic and meaning-centered interventions can be characterized and which methodological factors account for its comparatively narrow evidence base. First, it is argued that logotherapy comprises both an anthropological framework and a set of specific techniques, which complicates its operationalization as a testable treatment package. Second, central lines of evidence are summarized: the extensive, largely correlational research using meaning-in-life questionnaires, the meta-analytic integration of existential therapies, and randomized controlled trials of manualized meaning-centered programs in psycho-oncology. Overall, the findings suggest favorable effects of structured meaning-centered interventions but remain limited with respect to target populations, comparison conditions, and generalizability. Finally, the tension between the paradigm of disorder-specific efficacy trials and the contextual model of psychotherapy is discussed, together with the potential of process-oriented research that asks about mechanisms of change rather than school affiliation. The paper argues for a research agenda that respects anthropological assumptions while remaining methodologically compatible with mainstream psychotherapy research.

Keywords: logotherapy · evidence-based psychotherapy · meaning-centered psychotherapy · psychotherapy research · narrative review

1 Einleitung

Seit den 1990er-Jahren hat sich in der klinischen Psychologie ein Verständnis von Evidenz durchgesetzt, das psychotherapeutische Verfahren vor allem danach beurteilt, ob ihre Wirksamkeit für umschriebene Störungsbilder in kontrollierten Studien nachgewiesen wurde (Chambless & Hollon, 1998). Im deutschsprachigen Raum hat die Arbeit von

Grawe et al. (1994) diese Entwicklung maßgeblich geprägt, indem sie Psychotherapie programmatisch „von der Konfession zur Profession“ führen wollte. Ansätze, die sich primär über ein Menschenbild und weniger über ein störungsspezifisches Behandlungsprotokoll definieren, geraten in diesem Rahmen leicht unter Rechtfertigungsdruck.

Die von Viktor E. Frankl begründete Logotherapie ist hierfür ein instruktives Beispiel. Sie wurde in zahlreichen Sprachen rezipiert, hat die humanistische und existenzielle Psychotherapie nachhaltig beeinflusst und ist in Beratung, Seelsorge und Palliativversorgung präsent. Gleichzeitig wird sie in Leitlinien und Lehrbüchern der evidenzbasierten Psychotherapie kaum als eigenständiges Verfahren geführt. Der vorliegende narrative Review möchte diese Diskrepanz nicht vorschnell auflösen, sondern ihre Gründe rekonstruieren. Er stützt sich auf eine selektive, an der Relevanz für die Fragestellung orientierte Auswahl der Literatur und erhebt keinen Anspruch auf systematische Vollständigkeit.

2 Logotherapie zwischen Anthropologie und Behandlungsverfahren

Frankl selbst hat die Logotherapie nicht als Konkurrenzverfahren zu anderen Psychotherapien, sondern als deren Ergänzung verstanden (Frankl, 1946). Im Zentrum steht ein Menschenbild, das neben der somatischen und psychischen eine geistige, „noetische“ Dimension annimmt. Aus dieser Dimension leitet Frankl Freiheit, Verantwortlichkeit und den „Willen zum Sinn“ als primäre Motivation ab (Frankl, 1969). Psychisches Leiden kann demnach unter anderem dann entstehen, wenn dieser Wille zum Sinn frustriert wird; Frankl spricht in diesem Zusammenhang von „noogenen Neurosen“ und von einem verbreiteten „existenziellen Vakuum“.

Neben dieser anthropologischen Grundlegung hat Frankl spezifische Techniken beschrieben, insbesondere die paradoxe Intention zur Behandlung von Erwartungsangst und Zwangssymptomen sowie die Dereflexion bei übermäßiger Selbstbeobachtung (Frankl, 1960). Spätere Vertreterinnen und Vertreter haben die Methodik weiterentwickelt, etwa im Sinne einer Einstellungsmodulation oder des sokratischen Dialogs, und die Existenzanalyse hat sich zu einem eigenständigen, stärker phänomenologisch ausgerichteten Verfahren ausdifferenziert (Längle, 2013).

Für die Forschung ergibt sich daraus ein grundlegendes Problem: Es ist nicht ohne Weiteres bestimmbar, was eigentlich geprüft werden soll. Wird „Logotherapie“ als Haltung verstanden, die eine beliebige Behandlung durchdringt, lässt sie sich kaum gegen eine Kontrollbedingung abgrenzen. Wird sie hingegen auf einzelne Techniken reduziert, verliert sie gerade jene Eigenschaften, die ihre Vertreterinnen und Vertreter für zentral halten. Diese Spannung durchzieht die gesamte Evidenzdiskussion.

3 Zum Stand der empirischen Forschung

Eine erste Forschungslinie betrifft nicht die Wirksamkeit der Logotherapie, sondern die Validität ihrer Grundannahmen. Bereits Crumbaugh und Maholick (1964) entwickelten mit dem Purpose in Life Test ein Instrument, um Frankls Konzept des existenziellen Vakuums psychometrisch zugänglich zu machen. In der Folge entstand eine umfangreiche Literatur, die Zusammenhänge zwischen erlebtem Lebenssinn und psychischer Gesundheit untersuchte; eine annotierte Bibliografie dieser Arbeiten haben Batthyány und Guttmann (2006) vorgelegt. Diese Studien sind überwiegend korrelativ angelegt und erlauben daher keine Aussagen über die Wirksamkeit therapeutischer Interventionen, stützen aber die Annahme, dass Sinnerleben ein klinisch bedeutsames Merkmal ist. Die neuere Sinnforschung hat diese Befunde mit eigenständigen Instrumenten und Modellen erweitert (Park, 2010; Steger et al., 2006).

Eine zweite Forschungslinie bilden kontrollierte Interventionsstudien. Hier ist zunächst festzuhalten, dass Studien zur „klassischen“ Logotherapie im engeren Sinn vergleichsweise selten sind und häufig kleine Stichproben, unklare Manualisierung oder fehlende aktive Kontrollbedingungen aufweisen. Eine wichtige Integrationsleistung stellt die Meta-Analyse von Vos et al. (2015) dar, die randomisiert-kontrollierte Studien zu verschiedenen Formen existenzieller Therapie zusammenfasste. Die Autoren fanden Hinweise auf günstige Effekte insbesondere für strukturierte, explizit sinnzentrierte Interventionen, während die Befundlage für andere existenzielle Ansätze weniger eindeutig ausfiel. Zugleich betonen sie die Heterogenität der eingeschlossenen Studien und Populationen.

Die methodisch am besten untersuchten Programme stammen aus der Psychoonkologie. Die von Breitbart und Kolleginnen und Kollegen entwickelte Meaning-Centered Group Psychotherapy, die explizit auf Frankls Werk aufbaut, wurde zunächst in einer randomisierten Pilotstudie (Breitbart et al., 2010) und später in einer größeren randomisierten Studie mit aktiver Kontrollbedingung untersucht (Breitbart et al., 2015). In beiden Studien zeigten sich

im Vergleich zu einer unterstützenden Gruppenpsychotherapie Vorteile hinsichtlich spirituellen Wohlbefindens und erlebten Sinns sowie Hinweise auf eine Reduktion von Hoffnungslosigkeit und Todeswünschen. Diese Befunde sind bedeutsam, weil sie zeigen, dass sinnzentrierte Interventionen den Standards kontrollierter Forschung genügen können. Sie beziehen sich allerdings auf eine spezifische Population und lassen sich nicht ohne Weiteres auf andere klinische Kontexte übertragen.

4 Methodische Herausforderungen

Mehrere Faktoren erklären, warum die Evidenzbasis der Logotherapie trotz ihrer langen Tradition schmal geblieben ist. Erstens war die logotherapeutische Bewegung über weite Strecken stärker in Praxis, Lehre und Beratung als in universitärer Forschung verankert. Zweitens erschwert die bereits beschriebene Doppelstruktur von Anthropologie und Technik die Manualisierung. Drittens passen die primären Zielgrößen der Logotherapie – Sinnerleben, Werteverwirklichung, Einstellung zum unabänderlichen Leid – nur bedingt zu den Symptomskalen, die in störungsspezifischen Wirksamkeitsstudien üblicherweise als Hauptzielkriterien dienen.

Hinzu kommt eine grundsätzlichere Frage. Wampold und Imel (2015) haben dem medizinischen Modell der Psychotherapie, das spezifische Techniken als hauptsächliche Wirkquelle betrachtet, ein Kontextmodell gegenübergestellt, das der therapeutischen Beziehung, plausiblen Erklärungsmodellen und der Erwartung von Besserung erhebliches Gewicht zumisst. Auch Grawe (1998) hat mit seinen allgemeinen Wirkfaktoren eine schulenübergreifende Perspektive vorgeschlagen. Aus dieser Sicht wäre die Frage, ob „die Logotherapie“ als Markenverfahren wirksam ist, weniger ergiebig als die Frage, welche ihrer Elemente auf welche Weise zur Veränderung beitragen. Eine Übersicht zur Rolle allgemeiner Faktoren mahnt allerdings zugleich zur Vorsicht, da auch die Befundlage zu diesen Faktoren methodisch komplex ist (Cuijpers et al., 2019).

Ein weiteres Problem betrifft die Vergleichsbedingungen. Werden sinnzentrierte Interventionen mit Wartelisten oder Standardversorgung verglichen, lassen sich unspezifische Effekte wie Zuwendung, Strukturierung und Erwartung nicht von spezifischen Wirkungen trennen. Aktive Kontrollbedingungen, wie sie in den psychoonkologischen Studien verwendet wurden (Breitbart et al., 2015), stellen daher einen methodischen Fortschritt dar. Darüber hinaus fehlt es bislang weitgehend an Studien, die sinnzentrierte Interventionen direkt mit etablierten störungsspezifischen Verfahren vergleichen oder ihre Wirksamkeit als ergänzendes Modul innerhalb solcher Verfahren prüfen.

5 Perspektiven einer prozessorientierten Forschung

Eine Möglichkeit, die beschriebene Spannung produktiv zu wenden, liegt in der Erforschung von Veränderungsmechanismen. Kazdin (2007) hat dafür argumentiert, Mediatoren und Mechanismen therapeutischer Veränderung systematisch zu untersuchen, statt sich auf den Vergleich von Behandlungspaketen zu beschränken. Für sinnzentrierte Ansätze liegt es nahe, Veränderungen im erlebten Sinn, in der Wertorientierung oder in der Einstellung gegenüber unveränderlichen Lebensumständen als mögliche Mechanismen zu konzipieren und deren zeitliche Abfolge im Verhältnis zur Symptomveränderung zu prüfen.

Diese Perspektive fügt sich in die Debatte um eine prozessbasierte Psychotherapie ein, die evidenzbasierte Prozesse statt Markenverfahren in den Mittelpunkt stellt (Hofmann & Hayes, 2019). Für die Logotherapie bietet ein solcher Rahmen die Chance, ihre Konzepte in eine gemeinsame Sprache mit anderen Verfahren zu übersetzen, ohne ihr Menschenbild aufzugeben. Voraussetzung ist allerdings eine präzise Operationalisierung der postulierten Prozesse, eine sorgfältige Instrumentenwahl und die Bereitschaft, auch nicht hypothesenkonforme Ergebnisse ernst zu nehmen.

Aus dieser Perspektive ergeben sich konkrete Forschungsfragen: Geht eine Zunahme des erlebten Sinns der Abnahme depressiver Symptome zeitlich voraus, oder folgt sie ihr? Welche Patientengruppen profitieren besonders von einer expliziten Thematisierung von Sinn und Werten? Unter welchen Bedingungen kann die Sinnsuche, die in manchen Untersuchungen mit Belastung einhergeht (Steger et al., 2006), therapeutisch produktiv werden? Für die Beantwortung solcher Fragen sind intensive Längsschnittdesigns, systematische Einzelfallanalysen und Mediationsmodelle mit wiederholten Messungen besser geeignet als einmalige Vorher-nachher-Vergleiche.

6 Fazit

Die Frage, ob Logotherapie „evidenzbasiert“ ist, lässt sich nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten. Für die Grundannahme, dass

Sinnerleben ein klinisch relevantes Merkmal ist, liegt eine breite, wenn auch überwiegend korrelative Befundbasis vor. Für manualisierte sinnzentrierte Interventionen in der Psychoonkologie existieren kontrollierte Studien mit ermutigenden Ergebnissen. Für die Logotherapie als allgemeines psychotherapeutisches Verfahren ist die Evidenz dagegen begrenzt. Eine zukunftsfähige Forschungsagenda sollte daher weniger auf die Legitimation einer Schule als auf die Klärung von Mechanismen, Indikationen und Grenzen sinnzentrierter Arbeit zielen.

Für die Praxis folgt daraus eine Haltung begründeter Bescheidenheit. Logotherapeutische Konzepte können Behandlungen bereichern, insbesondere dort, wo Fragen nach Sinn, Werten und dem Umgang mit Unabänderlichem im Vordergrund stehen. Sie sollten jedoch nicht als Ersatz für Verfahren dargestellt werden, deren Wirksamkeit für bestimmte Störungsbilder gut belegt ist. Eine solche Selbstbeschränkung entspricht im Übrigen Frankls eigenem Verständnis der Logotherapie als Ergänzung, nicht als Ersatz anderer Psychotherapien (Frankl, 1946).

Literatur

Batthyány, A., & Guttmann, D. (2006). Empirical research in logotherapy and meaning-oriented psychotherapy: An annotated bibliography. Zeig, Tucker & Theisen.

Breitbart, W., Rosenfeld, B., Gibson, C., Pessin, H., Poppito, S., Nelson, C., Tomarken, A., Timm, A. K., Berg, A., Jacobson, C., Sorger, B., Abbey, J., & Olden, M. (2010). Meaning-centered group psychotherapy for patients with advanced cancer: A pilot randomized controlled trial. Psycho-Oncology, 19(1), 21–28.

Breitbart, W., Rosenfeld, B., Pessin, H., Applebaum, A., Kulikowski, J., & Lichtenthal, W. G. (2015). Meaning-centered group psychotherapy: An effective intervention for improving psychological well-being in patients with advanced cancer. Journal of Clinical Oncology, 33(7), 749–754.

Chambless, D. L., & Hollon, S. D. (1998). Defining empirically supported therapies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66(1), 7–18.

Crumbaugh, J. C., & Maholick, L. T. (1964). An experimental study in existentialism: The psychometric approach to Frankl's concept of noogenic neurosis. Journal of Clinical Psychology, 20(2), 200–207.

Cuijpers, P., Reijnders, M., & Huibers, M. J. H. (2019). The role of common factors in psychotherapy outcomes. Annual Review of Clinical Psychology, 15, 207–231.

Frankl, V. E. (1946). Ärztliche Seelsorge. Deuticke.

Frankl, V. E. (1960). Paradoxical intention: A logotherapeutic technique. American Journal of Psychotherapy, 14(3), 520–535.

Frankl, V. E. (1969). The will to meaning: Foundations and applications of logotherapy. New American Library.

Grawe, K. (1998). Psychologische Therapie. Hogrefe.

Grawe, K., Donati, R., & Bernauer, F. (1994). Psychotherapie im Wandel: Von der Konfession zur Profession. Hogrefe.

Hofmann, S. G., & Hayes, S. C. (2019). The future of intervention science: Process-based therapy. Clinical Psychological Science, 7(1), 37–50.

Kazdin, A. E. (2007). Mediators and mechanisms of change in psychotherapy research. Annual Review of Clinical Psychology, 3, 1–27.

Längle, A. (2013). Lehrbuch zur Existenzanalyse: Grundlagen. facultas.wuv.

Park, C. L. (2010). Making sense of the meaning literature: An integrative review of meaning making and its effects on adjustment to stressful life events. Psychological Bulletin, 136(2), 257–301.

Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53(1), 80–93.

Vos, J., Craig, M., & Cooper, M. (2015). Existential therapies: A meta-analysis of their effects on psychological outcomes. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(1), 115–128.

Wampold, B. E., & Imel, Z. E. (2015). The great psychotherapy debate: The evidence for what makes psychotherapy work (2nd ed.). Routledge.

ZITIERVORSCHLAG (ORIGINALFASSUNG)

Ashford, S. R., Pazer, S., & Whitcombe, E. M. (2026). Logotherapy and the Question of Evidence: A Narrative Review of the State of Research, Methodological Challenges, and Perspectives. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(1), 3–6. https://doi.org/10.5281/zenodo.23319975

LIZENZ, KORRESPONDENZ UND EINSATZ VON KI

Erscheint im offenen Zugang unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Korrespondenz: Redaktion der Zeitschrift. Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung generativer KI verfasst und von den Autorinnen und Autoren geprüft, die die volle Verantwortung für den Inhalt tragen.

Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie
HERAUSGEGEBEN VOM INSTITUT FÜR SINNZENTRIERTE PSYCHOLOGIE

Jahrgang 1 · Heft 1 · April 2026
S. 7–10 (Original) · Open Access · CC BY 4.0

THEORETISCHER BEITRAG

Lebenssinn als transdiagnostischer Faktor

Begriffliche Klärungen, theoretische Modelle und offene Fragen

Eleanor M. Whitcombe, Samuel R. Ashford und Sora Pazer
Institut für Sinnzentrierte Psychologie

Deutsche Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Originalfassung.

ZUSAMMENFASSUNG

Transdiagnostische Ansätze untersuchen psychologische Merkmale und Prozesse, die über verschiedene Störungsbilder hinweg an Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Beschwerden beteiligt sind. Der vorliegende theoretische Beitrag prüft, ob und in welchem Sinne Lebenssinn als transdiagnostischer Faktor konzipiert werden kann. Ausgehend von den Kriterien, die in der transdiagnostischen Literatur für entsprechende Konstrukte diskutiert werden, wird zunächst der Begriff des Lebenssinns präzisiert. Unterschieden werden das Vorhandensein von Sinn, die Suche nach Sinn sowie die Komponenten Kohärenz, Zielorientierung und Bedeutsamkeit. Anschließend werden drei Modellvorstellungen gegenübergestellt: Lebenssinn als Vulnerabilitäts- bzw. Schutzfaktor, als Ergebnis gelingender Bedeutungsbildung nach belastenden Ereignissen und als Ausdruck übergreifender Motivationsstrukturen. Es wird argumentiert, dass ein Mangel an erlebtem Sinn weniger als eigenständiger Mechanismus denn als Knotenpunkt verstanden werden sollte, an dem motivationale, kognitive und emotionale Prozesse zusammenlaufen. Abschließend werden Implikationen für Diagnostik und Psychotherapie diskutiert sowie methodische Anforderungen formuliert, die für eine empirische Prüfung des transdiagnostischen Status von Lebenssinn erforderlich wären, insbesondere längsschnittliche Designs, die Trennung konzeptuell überlappender Konstrukte und die Berücksichtigung kultureller Variabilität.

Schlüsselwörter: Lebenssinn · Transdiagnostik · Psychopathologie · Bedeutungsbildung · Schutzfaktoren

ABSTRACT

Transdiagnostic approaches investigate psychological characteristics and processes that contribute to the onset and maintenance of psychological problems across diagnostic categories. This theoretical paper examines whether, and in what sense, meaning in life can be conceptualized as a transdiagnostic factor. Drawing on criteria discussed in the transdiagnostic literature, the paper first clarifies the concept of meaning in life, distinguishing between presence of meaning and search for meaning as well as between the components of coherence, purpose, and significance. Three models are then contrasted: meaning in life as a vulnerability or protective factor, as an outcome of successful meaning making after stressful events, and as an expression of overarching motivational structures. It is argued that a lack of experienced meaning should be understood less as a distinct mechanism than as a nodal point at which motivational, cognitive, and emotional processes converge. Finally, implications for assessment and psychotherapy are discussed, and methodological requirements for an empirical test of the transdiagnostic status of meaning in life are outlined, in particular longitudinal designs, the separation of conceptually overlapping constructs, and attention to cultural variability.

Keywords: meaning in life · transdiagnostic approach · psychopathology · meaning making · protective factors

1 Einleitung

Die kategoriale Klassifikation psychischer Störungen hat sich für Verständigung, Versorgung und Forschung als unverzichtbar erwiesen. Zugleich sind ihre Grenzen seit Langem bekannt: Hohe Komorbiditätsraten, unscharfe Übergänge zwischen Diagnosen und die Beobachtung, dass ähnliche psychologische Prozesse bei unterschiedlichen Störungen wirksam sind, haben zu einer transdiagnostischen Perspektive geführt. Harvey et al. (2004) haben in einer einflussreichen Monografie gezeigt, dass Prozesse wie selektive Aufmerksamkeit, repetitives negatives Denken oder Vermeidungsverhalten über zahlreiche Störungsbilder hinweg auftreten. Auf struktureller Ebene wurde zudem diskutiert, ob sich ein allgemeiner

Psychopathologiefaktor identifizieren lässt (Caspi et al., 2014).

Vor diesem Hintergrund liegt die Frage nahe, ob auch Lebenssinn – oder sein Fehlen – als transdiagnostischer Faktor verstanden werden kann. Die Logotherapie hat eine solche Annahme in gewisser Weise vorweggenommen, indem sie die Frustration des Willens zum Sinn als Bedingung beschrieb, die sich in unterschiedlichen Symptomen äußern kann (Frankl, 1969). Der vorliegende Beitrag prüft diese Intuition im Licht gegenwärtiger theoretischer Kriterien. Er versteht sich als konzeptuelle Analyse und nicht als Zusammenfassung eigener empirischer Daten.

2 Kriterien für transdiagnostische Konstrukte

Nolen-Hoeksema und Watkins (2011) haben eine Heuristik vorgeschlagen, mit der sich transdiagnostische Modelle präzisieren lassen. Sie unterscheiden distale Risikofaktoren, die die Vulnerabilität erhöhen, proximale Prozesse, die unmittelbar an der Symptombildung beteiligt sind, und moderierende Bedingungen, die erklären, warum ein gemeinsamer Faktor bei verschiedenen Personen zu unterschiedlichen Störungen führt. Ein Konstrukt verdient demnach nicht schon deshalb die Bezeichnung „transdiagnostisch", weil es mit mehreren Störungen korreliert. Erforderlich ist vielmehr ein theoretisch begründetes Modell darüber, wie es auf die Entstehung und Aufrechterhaltung von Symptomen einwirkt.

Für den Lebenssinn ergibt sich daraus eine doppelte Aufgabe. Erstens muss geklärt werden, was genau unter Lebenssinn verstanden wird. Zweitens ist zu bestimmen, auf welcher Ebene des Modells – als distaler Faktor, als proximaler Prozess oder als Moderator – er angesiedelt sein soll. Beide Fragen werden in der Literatur nicht immer hinreichend auseinandergehalten.

3 Begriffliche Präzisierung

Steger et al. (2006) haben mit der Unterscheidung zwischen dem Vorhandensein von Sinn und der Suche nach Sinn eine für die empirische Forschung folgenreiche Differenzierung eingeführt. Während das erlebte Vorhandensein von Sinn in der Regel mit Wohlbefinden einhergeht, ist der Zusammenhang der Sinnsuche mit psychischer Gesundheit komplexer und offenbar vom Kontext abhängig. Martela und Steger (2016) haben darüber hinaus drei Facetten des Sinnerlebens unterschieden: Kohärenz im Sinne der Verstehbarkeit des eigenen Lebens, Zielorientierung im Sinne einer motivierenden Ausrichtung auf wertgeschätzte Ziele und Bedeutsamkeit im Sinne des Erlebens, dass das eigene Leben wertvoll ist und zählt.

Schnell (2009) hat zudem gezeigt, dass zwischen den Quellen, aus denen Menschen Sinn beziehen, und dem globalen Sinnerleben unterschieden werden sollte. Diese Unterscheidung ist klinisch bedeutsam: Ein Mangel an erlebtem Sinn kann auf den Verlust einzelner Sinnquellen, auf eine geringe Vielfalt solcher Quellen oder auf eine fehlende Integration in ein übergreifendes Selbstverständnis zurückgehen. Ferner hat Schnell (2020) auf den Zustand der „existenziellen Indifferenz" hingewiesen, bei dem weder Sinn erlebt noch gesucht wird – ein Zustand, der sich von einer akuten Sinnkrise deutlich unterscheidet.

Für die transdiagnostische Frage folgt daraus, dass „Lebenssinn" kein einheitliches Konstrukt ist. Wer von Sinn als transdiagnostischem Faktor spricht, muss angeben, welche Facette gemeint ist, da Kohärenz, Zielorientierung und Bedeutsamkeit potenziell mit unterschiedlichen psychopathologischen Prozessen verknüpft sind.

Hinzu kommt, dass Sinnerleben und Sinnsuche nicht als Gegenpole einer einzigen Dimension verstanden werden sollten (Steger et al., 2006). Eine Person kann ihr Leben als sinnvoll erleben und zugleich nach vertieftem Sinn suchen; umgekehrt kann jemand wenig Sinn erleben, ohne aktiv danach zu suchen. Diese Konstellationen haben vermutlich unterschiedliche klinische Bedeutung, was bei der Formulierung transdiagnostischer Hypothesen berücksichtigt werden muss.

4 Drei Modellvorstellungen

Ein erstes Modell versteht erlebten Sinn als Schutzfaktor und seinen Mangel als Vulnerabilitätsfaktor. Diese Sichtweise ist mit salutogenetischen Überlegungen verwandt, wie sie Antonovsky (1987) mit dem Konzept des Kohärenzgefühls formuliert hat, in dem die Sinnhaftigkeit als motivationale Komponente eine zentrale Stellung einnimmt. In diesem Modell wäre Lebenssinn ein distaler Faktor im Sinne von Nolen-Hoeksema und Watkins (2011), der die Wahrscheinlichkeit unterschiedlicher Störungen beeinflusst, ohne deren spezifische Gestalt festzulegen.

Ein zweites Modell betont die Prozessdimension. Park (2010) beschreibt in ihrem Meaning-Making-Modell, wie belastende Ereignisse eine Diskrepanz zwischen globalen Bedeutungsstrukturen und der situativen Bewertung eines Ereignisses erzeugen, die

durch Prozesse der Bedeutungsbildung verringert werden kann. Psychische Beschwerden ließen sich in diesem Rahmen als Ausdruck nicht gelingender Bedeutungsbildung verstehen. Hier ist Sinn nicht primär ein stabiles Merkmal, sondern ein Ergebnis fortlaufender Verarbeitung, das proximal an der Aufrechterhaltung von Symptomen beteiligt sein kann.

Ein drittes Modell schließlich deutet Sinnerleben als Ausdruck übergreifender Motivationsstrukturen. Baumeister (1991) hat Sinnbedürfnisse in Bezug auf Zweck, Werte, Wirksamkeit und Selbstwert beschrieben. Aus dieser Perspektive verweist ein Mangel an Sinn auf eine Störung motivationaler Ausrichtung, die sich etwa in Antriebsminderung, Vermeidungsverhalten oder kompensatorischen Strategien äußern kann. Auch Yalom (1980) hat Sinnlosigkeit als eine der existenziellen Grundgegebenheiten beschrieben, mit der Menschen in sehr unterschiedlicher, teils dysfunktionaler Weise umgehen.

Die Logotherapie lässt sich keinem dieser Modelle eindeutig zuordnen. Frankls Konzept der noogenen Neurose beschreibt Beschwerden, die primär aus einem existenziellen Konflikt oder einer Sinnfrustration hervorgehen (Frankl, 1969). Damit nimmt es eine spezifische Ätiologie an, die sich von psychogenen und somatogenen Störungen unterscheiden soll. Zugleich betont Frankl, dass ein existenzielles Vakuum auch ohne Krankheitswert bestehen und sich in unterschiedlichen Ausdrucksformen zeigen kann. Aus transdiagnostischer Sicht ist diese Doppelfunktion bemerkenswert, weil sie Sinnfrustration sowohl als spezifische Ursache als auch als unspezifischen Hintergrundfaktor konzipiert.

5 Sinn als Knotenpunkt: Eine integrative Deutung

Die drei Modelle schließen einander nicht aus. Es spricht vieles dafür, einen Mangel an erlebtem Sinn weniger als eigenständigen, isolierbaren Mechanismus denn als Knotenpunkt zu verstehen, an dem motivationale, kognitive und emotionale Prozesse zusammenlaufen. Befunde, nach denen positiver Affekt das momentane Sinnerleben beeinflusst (King et al., 2006), verdeutlichen, dass Sinnerleben nicht unabhängig von der affektiven Lage einer Person ist. Umgekehrt ist plausibel, dass eine stabile Wertorientierung affektive Krisen abpuffern kann.

Eine solche Knotenpunkt-Deutung hat Konsequenzen für die Forschung. Sie warnt davor, Sinnerleben als bloße Spiegelung depressiver Symptomatik zu behandeln, ebenso wie davor, es zu einem allumfassenden Erklärungsprinzip zu überhöhen. Heintzelman und King (2014) haben zudem darauf hingewiesen, dass die meisten Menschen ihr Leben als recht sinnvoll beschreiben. Ein klinisch relevanter Sinnmangel ist demnach eher die Ausnahme als die Regel, was für die Bestimmung von Schwellenwerten und Risikogruppen bedeutsam ist.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Richtung der Zusammenhänge. Querschnittliche Korrelationen zwischen geringem Sinnerleben und psychischen Beschwerden sind mit mehreren Kausalannahmen vereinbar: Ein Mangel an Sinn kann Beschwerden begünstigen, Beschwerden können das Sinnerleben beeinträchtigen, oder beide können auf gemeinsame dritte Faktoren zurückgehen. Ein transdiagnostisches Modell muss diese Möglichkeiten explizit unterscheiden und darf aus Zusammenhängen nicht vorschnell auf Wirkrichtungen schließen.

6 Implikationen und offene Fragen

Für die Diagnostik legt die Analyse nahe, Sinnerleben facettenspezifisch und störungsübergreifend zu erfassen, statt es lediglich als Begleitvariable zu erheben. Für die Psychotherapie ergibt sich die Überlegung, ob sinnzentrierte Interventionen als ergänzende Module in unterschiedlichen Behandlungskontexten eingesetzt werden können. Dies entspräche Frankls Selbstverständnis der Logotherapie als Ergänzung anderer Verfahren.

Für eine empirische Prüfung des transdiagnostischen Status von Lebenssinn wären insbesondere längsschnittliche Designs erforderlich, die zeitliche Abfolgen zwischen Sinnerleben und Symptomentwicklung abbilden, ferner eine sorgfältige Trennung konzeptuell überlappender Konstrukte wie Hoffnungslosigkeit, Wohlbefinden oder Selbstwirksamkeit sowie die Berücksichtigung kultureller Variabilität in der Bedeutung von Sinn. Solange diese Anforderungen nicht erfüllt sind, ist die Rede von Lebenssinn als transdiagnostischem Faktor als heuristisch fruchtbare Hypothese, nicht als gesicherter Befund zu verstehen.

Für die therapeutische Praxis ist zudem zu bedenken, dass die Thematisierung von Sinn nicht zu jedem Zeitpunkt einer Behandlung angemessen ist. In akuten Krisen, bei schwerer depressiver Symptomatik oder bei ausgeprägter Antriebsminderung kann die explizite Frage nach dem Sinn des eigenen Lebens überfordern oder Gefühle des Versagens verstärken. Ein transdiagnostisches Verständnis von Sinn spricht

daher nicht für eine undifferenzierte Anwendung sinnzentrierter Techniken, sondern für eine sorgfältige Indikationsstellung, die den Zustand der Person, ihre Ressourcen und den Behandlungsverlauf berücksichtigt.

Literatur

Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well. Jossey-Bass.

Baumeister, R. F. (1991). Meanings of life. Guilford Press.

Caspi, A., Houts, R. M., Belsky, D. W., Goldman-Mellor, S. J., Harrington, H., Israel, S., Meier, M. H., Ramrakha, S., Shalev, I., Poulton, R., & Moffitt, T. E. (2014). The p factor: One general psychopathology factor in the structure of psychiatric disorders? Clinical Psychological Science, 2(2), 119–137.

Frankl, V. E. (1969). The will to meaning: Foundations and applications of logotherapy. New American Library.

Harvey, A. G., Watkins, E., Mansell, W., & Shafran, R. (2004). Cognitive behavioural processes across psychological disorders: A transdiagnostic approach to research and treatment. Oxford University Press.

Heintzelman, S. J., & King, L. A. (2014). Life is pretty meaningful. American Psychologist, 69(6), 561–574.

King, L. A., Hicks, J. A., Krull, J. L., & Del Gaiso, A. K. (2006). Positive affect and the experience of meaning in life. Journal of Personality and Social Psychology, 90(1), 179–196.

Martela, F., & Steger, M. F. (2016). The three meanings of meaning in life: Distinguishing coherence, purpose, and significance. The Journal of Positive Psychology, 11(5), 531–545.

Nolen-Hoeksema, S., & Watkins, E. R. (2011). A heuristic for developing transdiagnostic models of psychopathology: Explaining multifinality and divergent trajectories. Perspectives on Psychological Science, 6(6), 589–609.

Park, C. L. (2010). Making sense of the meaning literature: An integrative review of meaning making and its effects on adjustment to stressful life events. Psychological Bulletin, 136(2), 257–301.

Schnell, T. (2009). The Sources of Meaning and Meaning in Life Questionnaire (SoMe): Relations to demographics and well-being. The Journal of Positive Psychology, 4(6), 483–499.

Schnell, T. (2020). Psychologie des Lebenssinns (2. Aufl.). Springer.

Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53(1), 80–93.

Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. Basic Books.

ZITIERVORSCHLAG (ORIGINALFASSUNG)

Whitcombe, E. M., Ashford, S. R., & Pazer, S. (2026). Meaning in Life as a Transdiagnostic Factor: Conceptual Clarifications, Theoretical Models, and Open Questions. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(1), 7–10.

LIZENZ, KORRESPONDENZ UND EINSATZ VON KI

Erscheint im offenen Zugang unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Korrespondenz: Redaktion der Zeitschrift. Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung generativer KI verfasst und von den Autorinnen und Autoren geprüft, die die volle Verantwortung für den Inhalt tragen.

Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie
HERAUSGEGEBEN VOM INSTITUT FÜR SINNZENTRIERTE PSYCHOLOGIE

Jahrgang 1 · Heft 1 · April 2026
S. 11–13 (Original) · Open Access · CC BY 4.0

THEORETISCHER BEITRAG

Paradoxe Intention und moderne Expositionsverfahren

Ein theoretischer Vergleich von Wirkannahmen, Vorgehen und Grenzen

Samuel R. Ashford, Eleanor M. Whitcombe und Sora Pazer
Institut für Sinnzentrierte Psychologie

Deutsche Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Originalfassung.

ZUSAMMENFASSUNG

Die paradoxe Intention zählt zu den bekanntesten Techniken der Logotherapie. Viktor E. Frankl beschrieb sie bereits in den 1930er- bis 1950er-Jahren als Verfahren zur Unterbrechung der Erwartungsangst bei Phobien und Zwangssymptomen. Der vorliegende Beitrag vergleicht die paradoxe Intention auf theoretischer Ebene mit gegenwärtigen Expositionsverfahren der kognitiven Verhaltenstherapie, insbesondere mit dem Modell der emotionalen Verarbeitung und dem Ansatz des inhibitorischen Lernens. Herausgearbeitet werden zunächst deutliche Gemeinsamkeiten: Beide Zugänge zielen auf die Aufgabe von Vermeidungs- und Kontrollverhalten, fördern die Konfrontation mit gefürchteten Erfahrungen und ermöglichen korrigierende Lernerfahrungen. Zugleich bestehen Unterschiede in der anthropologischen Begründung, in der Rolle des Humors und der Selbstdistanzierung sowie in der Strukturierung des Vorgehens. Anschließend wird diskutiert, inwieweit Konzepte wie ironische Prozesse der Gedankenkontrolle, metakognitive Modelle und kognitive Defusion als Brücken zwischen beiden Traditionen dienen können. Der Beitrag schließt mit einer Erörterung von Indikationsgrenzen und mit Vorschlägen für eine präzisere theoretische Verortung der paradoxen Intention innerhalb der gegenwärtigen Psychotherapieforschung, ohne ihre eigenständige existenzanalytische Begründung aufzugeben.

Schlüsselwörter: Paradoxe Intention · Exposition · Inhibitorisches Lernen · Selbstdistanzierung · Angststörungen

ABSTRACT

Paradoxical intention is among the best-known techniques of logotherapy. Viktor E. Frankl described it as early as the period between the 1930s and the 1950s as a method for interrupting anticipatory anxiety in phobias and obsessive-compulsive symptoms. This paper compares paradoxical intention at a theoretical level with contemporary exposure-based procedures in cognitive behavioral therapy, in particular with emotional processing theory and the inhibitory learning approach. First, substantial similarities are identified: both approaches aim at relinquishing avoidance and control behaviors, encourage confrontation with feared experiences, and enable corrective learning. At the same time, there are differences in their anthropological rationale, in the role of humor and self-distancing, and in how the procedure is structured. The paper then discusses to what extent concepts such as ironic processes of mental control, metacognitive models, and cognitive defusion may serve as bridges between the two traditions. It concludes with a discussion of the limits of indication and with suggestions for a more precise theoretical placement of paradoxical intention within current psychotherapy research, without abandoning its distinct existential-analytic foundation.

Keywords: paradoxical intention · exposure therapy · inhibitory learning · self-distancing · anxiety disorders

1 Einleitung

Unter den Techniken der Logotherapie hat die paradoxe Intention die größte Verbreitung über die eigene Schule hinaus erfahren. Frankl (1960) beschrieb sie in einem viel zitierten Aufsatz als Verfahren, bei dem Patientinnen und Patienten angeleitet werden, das Gefürchtete gerade herbeizuwünschen oder absichtlich hervorzurufen, statt es angestrengt zu vermeiden. In seiner Darstellung der Neurosenlehre hat er diesen Ansatz systematisch in ein Modell der Erwartungsangst eingebettet (Frankl, 1956).

Seither hat sich die Behandlung von Angst- und Zwangsstörungen erheblich weiterentwickelt. Expositionsbasierte Verfahren gehören heute zu den am besten untersuchten psychotherapeutischen Interventionen überhaupt (Abramowitz et al., 2019).

Es liegt daher nahe, die paradoxe Intention mit diesen Verfahren zu vergleichen. Der vorliegende Beitrag tut dies auf theoretischer Ebene. Er fragt, welche Wirkannahmen beiden Zugängen zugrunde liegen, wo sie konvergieren und wo sie sich unterscheiden.

Der Vergleich ist auch deshalb lohnend, weil die paradoxe Intention in der Literatur gelegentlich als Vorläufer verhaltenstherapeutischer Techniken bezeichnet wird. Eine solche Einordnung ist historisch nachvollziehbar, wird aber dem Selbstverständnis Frankls nur zum Teil gerecht. Es gilt daher, sowohl die funktionale Verwandtschaft als auch die eigenständige Begründung ernst zu nehmen.

2 Die paradoxe Intention im logotherapeutischen Verständnis

Frankls Ausgangspunkt ist ein zirkuläres Modell: Ein Symptom löst die Befürchtung aus, es könne wiederkehren; diese Erwartungsangst begünstigt ihrerseits das erneute Auftreten des Symptoms, was die Befürchtung weiter verstärkt (Frankl, 1956). Typische Reaktionsmuster auf diesen Zirkel sind nach Frankl die Flucht vor der Angst bei phobischen Beschwerden und der Kampf gegen die Zwangsidee bei Zwangssymptomen. Beide Muster tragen zur Verfestigung der Problematik bei.

Die paradoxe Intention setzt an dieser Stelle an. Sie fordert die betroffene Person auf, sich das Gefürchtete – etwa das Erröten, Zittern oder Schwitzen – bewusst und möglichst in übertriebener, humorvoller Form zu wünschen. Frankl (1960) betonte, dass diese Technik auf der spezifisch menschlichen Fähigkeit zur Selbstdistanzierung beruhe, die er der noetischen Dimension zurechnete. Der Humor ist dabei kein dekoratives Beiwerk, sondern ein zentrales Mittel, um Abstand vom Symptom zu gewinnen und die Angst ihrer Macht zu berauben.

Bemerkenswert ist, dass Frankl die paradoxe Intention nicht als bloße Technik verstand. Sie sollte der Person ermöglichen, sich nicht mit ihrer Angst zu identifizieren, sondern ihr gegenüber eine Haltung einzunehmen. Darin kommt die anthropologische Grundannahme der Logotherapie zum Ausdruck, dass der Mensch seinen psychischen Bedingungen nicht vollständig ausgeliefert ist, sondern zu ihnen Stellung nehmen kann.

Frankl unterschied die paradoxe Intention zudem von der Dereflexion. Während die paradoxe Intention auf die Erwartungsangst zielt, richtet sich die Dereflexion auf eine übersteigerte Selbstbeobachtung, die Frankl als Hyperreflexion bezeichnete und etwa bei Schlafstörungen und sexuellen Funktionsstörungen beschrieb (Frankl, 1956). Beiden Verfahren gemeinsam ist die Annahme, dass eine bestimmte Form angestrengter Selbstzuwendung das Problem aufrechterhält, das sie zu lösen sucht.

3 Expositionsverfahren: Von der emotionalen Verarbeitung zum inhibitorischen Lernen

Die theoretische Begründung der Exposition hat sich in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt. Foa und Kozak (1986) formulierten mit der Theorie der emotionalen Verarbeitung ein Modell, nach dem Angst in Gedächtnisstrukturen repräsentiert ist, die durch Aktivierung und die Aufnahme korrigierender Information verändert werden können. Habituation innerhalb und zwischen Übungssitzungen galt in diesem Modell als wichtiger Indikator gelingender Verarbeitung.

Craske et al. (2014) haben demgegenüber ein Modell des inhibitorischen Lernens vorgeschlagen. Danach wird die ursprüngliche Angstassoziation durch Exposition nicht gelöscht, sondern durch neu erlernte, hemmende Assoziationen ergänzt, die mit der ursprünglichen konkurrieren. Für die Praxis folgt daraus, dass weniger die Reduktion der Angst während der Übung als die Verletzung von Erwartungen, die Variabilität der Übungskontexte und der Verzicht auf Sicherheitsverhalten im Vordergrund stehen. Die Toleranz von Angst wird damit selbst zum Ziel.

Für die Praxis bedeutsam ist ferner, dass moderne Expositionsverfahren in der Regel auf einer sorgfältigen Fallkonzeption und einer überzeugenden Begründung beruhen, die Patientinnen und Patienten verständlich macht, warum die Konfrontation mit Angst sinnvoll ist (Abramowitz et al., 2019). Auch hier zeigt sich eine Parallele: Frankl legte Wert darauf, dass Betroffene den Mechanismus der Erwartungsangst verstehen, bevor sie die paradoxe Intention anwenden.

4 Konvergenzen

Aus der Perspektive des inhibitorischen Lernens erscheint die paradoxe Intention in neuem Licht. Indem Patientinnen und Patienten das Gefürchtete herbeiwünschen, geben sie Vermeidungs- und Kontrollstrategien auf und setzen sich der gefürchteten Erfahrung aus. Die Erwartung, dass das Symptom katastrophal eskalieren werde, wird dabei häufig nicht bestätigt. Funktional betrachtet enthält die paradoxe Intention damit zentrale Elemente einer Expositionsübung: Konfrontation, Verzicht auf Sicherheitsverhalten und Erwartungsverletzung.

Eine weitere Brücke bietet die Forschung zur Gedankenkontrolle. Wegner (1994) hat gezeigt, dass der Versuch, bestimmte Gedanken zu unterdrücken, unter bestimmten Bedingungen gerade zu deren vermehrtem Auftreten führen kann. Dieses Konzept ironischer Prozesse liefert eine experimentalpsychologisch fundierte Erklärung für die von Frankl klinisch beschriebene Beobachtung, dass der Kampf gegen ein Symptom dieses verstärken kann. Auch das metakognitive Modell von Wells (2009), das problematische Überzeugungen über die Kontrollierbarkeit und Gefährlichkeit eigener Gedanken in den Mittelpunkt stellt, weist hier Berührungspunkte auf.

Schließlich bestehen Parallelen zur kognitiven Defusion in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, bei der Gedanken als vorübergehende mentale Ereignisse betrachtet werden, statt sie als wörtliche Wahrheiten zu behandeln (Hayes et al., 2012). Manche Defusionsübungen, die mit Übertreibung, Wiederholung oder spielerischer Verfremdung arbeiten, ähneln in ihrer Struktur der humorvollen Distanzierung, die Frankl beschrieben hat.

5 Differenzen

Trotz dieser Konvergenzen wäre es verkürzend, die paradoxe Intention schlicht als frühe Form der Exposition zu deuten. Ein erster Unterschied betrifft die Begründung: Während Expositionsverfahren lern- und gedächtnispsychologisch fundiert sind, beruft sich Frankl auf eine anthropologische Fähigkeit zur Selbstdistanzierung. Ein zweiter Unterschied liegt in der Strukturierung. Moderne Expositionsprotokolle sind in der Regel sorgfältig geplant, mit Hierarchien, Erwartungsprüfungen und Nachbesprechungen. Die paradoxe Intention wurde dagegen häufig als kompakte, im Alltag anzuwendende Haltung vermittelt.

Ein dritter Unterschied betrifft die Rolle des Humors. In Expositionsverfahren ist Humor allenfalls ein förderlicher Kontextfaktor, in der paradoxen Intention dagegen konstitutiv. Ob und in welchem Maße Humor selbst zur Wirksamkeit beiträgt, ist eine offene empirische Frage. Hinzu kommt, dass paradoxe Interventionen in der Literatur unter sehr unterschiedlichen Bezeichnungen und Verfahrensweisen untersucht wurden. Eine frühe Meta-Analyse paradoxer Interventionen (Shoham-Salomon & Rosenthal, 1987) deutet zwar auf eine gewisse Wirksamkeit hin, verweist aber zugleich auf erhebliche Heterogenität, sodass Rückschlüsse auf die logotherapeutische Technik im engeren Sinn nur vorsichtig gezogen werden können.

Ein vierter Unterschied betrifft das Ziel. Expositionsverfahren richten sich primär auf die Reduktion von Angst und Vermeidung bzw. auf eine verbesserte Angsttoleranz. Für Frankl war die Überwindung der Erwartungsangst dagegen kein Selbstzweck, sondern Voraussetzung dafür, dass sich die Person wieder den Aufgaben und Werten ihres Lebens zuwenden kann. In dieser Hinsicht steht die paradoxe Intention der Akzeptanz- und Commitment-Therapie nahe, die Angstreduktion ebenfalls nicht als primäres Ziel betrachtet, sondern wertorientiertes Handeln in den Mittelpunkt stellt (Hayes et al., 2012).

6 Indikationsgrenzen und Ausblick

Bereits Frankl (1956) hat darauf hingewiesen, dass die paradoxe Intention nicht bei allen Beschwerdebildern angezeigt ist. Bei depressiven Zuständen mit Suizidalität etwa wäre eine Aufforderung, das Gefürchtete herbeizuwünschen, offenkundig kontraindiziert. Auch bei Zwangsgedanken mit aggressivem Inhalt bedarf es sorgfältiger Psychoedukation, damit die Technik nicht als Bagatellisierung erlebt wird. Ein tragfähiges Arbeitsbündnis und eine klare Begründung der Intervention sind daher unverzichtbar.

Für die künftige Forschung bietet das Modell des inhibitorischen Lernens einen Rahmen, in dem sich Hypothesen über die Wirkweise der paradoxen Intention präzise formulieren lassen, etwa zur Rolle der Erwartungsverletzung oder zum Beitrag von Humor und Selbstdistanzierung. Eine solche Integration würde die paradoxe Intention nicht ihrer existenzanalytischen Begründung berauben, sondern diese um eine anschlussfähige Mechanismusperspektive ergänzen.

Methodisch bieten sich für die Prüfung solcher Hypothesen Komponentenanalysen an, in denen etwa eine Expositionsbedingung mit und ohne humorvoll-paradoxe Instruktion verglichen wird. Auf diese Weise ließe sich klären, ob die paradoxe Formulierung über die Konfrontation hinaus einen eigenständigen Beitrag leistet. Ebenso wäre zu untersuchen, ob Personen mit ausgeprägter Neigung zur Gedankenunterdrückung oder mit metakognitiven Überzeugungen über die Gefährlichkeit eigener Gedanken besonders von einer paradoxen Haltung profitieren (Wegner, 1994; Wells, 2009).

Literatur

Abramowitz, J. S., Deacon, B. J., & Whiteside, S. P. H. (2019). Exposure therapy for anxiety: Principles and practice (2nd ed.). Guilford Press.

Craske, M. G., Treanor, M., Conway, C. C., Zbozinek, T., & Vervliet, B. (2014). Maximizing exposure therapy: An inhibitory learning approach. Behaviour Research and Therapy, 58, 10–23.

Foa, E. B., & Kozak, M. J. (1986). Emotional processing of fear: Exposure to corrective information. Psychological Bulletin, 99(1), 20–35.

Frankl, V. E. (1956). Theorie und Therapie der Neurosen: Einführung in Logotherapie und Existenzanalyse. Urban & Schwarzenberg.

Frankl, V. E. (1960). Paradoxical intention: A logotherapeutic technique. American Journal of Psychotherapy, 14(3), 520–535.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change (2nd ed.). Guilford Press.

Shoham-Salomon, V., & Rosenthal, R. (1987). Paradoxical interventions: A meta-analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55(1), 22–28.

Wegner, D. M. (1994). Ironic processes of mental control. Psychological Review, 101(1), 34–52.

Wells, A. (2009). Metacognitive therapy for anxiety and depression. Guilford Press.

ZITIERVORSCHLAG (ORIGINALFASSUNG)

Ashford, S. R., Whitcombe, E. M., & Pazer, S. (2026). Paradoxical Intention and Modern Exposure Procedures: A Theoretical Comparison of Assumed Mechanisms, Procedure, and Limitations. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(1), 11–13.

LIZENZ, KORRESPONDENZ UND EINSATZ VON KI

Erscheint im offenen Zugang unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Korrespondenz: Redaktion der Zeitschrift. Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung generativer KI verfasst und von den Autorinnen und Autoren geprüft, die die volle Verantwortung für den Inhalt tragen.

Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie
HERAUSGEGEBEN VOM INSTITUT FÜR SINNZENTRIERTE PSYCHOLOGIE
Jahrgang 1 · Heft 1 · April 2026
S. 14–17 (Original) · Open Access · CC BY 4.0

METHODENBEITRAG

Die Messung von Lebenssinn

Purpose in Life Test, Meaning in Life Questionnaire und LeBe/SoMe im konzeptuellen und methodischen Vergleich

Samuel R. Ashford, Sora Pazer und Eleanor M. Whitcombe
Institut für Sinnzentrierte Psychologie

Deutsche Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Originalfassung.

ZUSAMMENFASSUNG

Die empirische Erforschung von Lebenssinn ist untrennbar mit der Entwicklung geeigneter Messinstrumente verbunden. Der vorliegende Methodenbeitrag stellt drei Verfahrensfamilien vergleichend dar, die in Forschung und Praxis besonders häufig verwendet werden: den Purpose in Life Test, der in der Tradition der Logotherapie entwickelt wurde, den Meaning in Life Questionnaire mit seiner Unterscheidung zwischen dem Vorhandensein von und der Suche nach Sinn sowie den Fragebogen zu Lebensbedeutungen und Lebenssinn (LeBe) bzw. seine englischsprachige Fassung SoMe, der zusätzlich Quellen von Sinn erfasst. Ergänzend wird die Existenzskala als Instrument aus der existenzanalytischen Tradition berücksichtigt. Die Verfahren werden hinsichtlich ihrer theoretischen Fundierung, ihres Aufbaus, ihrer Konstruktabgrenzung und typischer Anwendungsfelder beschrieben. Im Zentrum steht dabei die Frage der Konstruktvalidität: Es wird diskutiert, inwieweit die Instrumente Sinnerleben von verwandten Konstrukten wie Wohlbefinden, Depressivität oder Lebenszufriedenheit abgrenzen und welche Facetten des Sinnerlebens sie jeweils abbilden. Abschließend werden Empfehlungen für die Instrumentenwahl in Forschung, Diagnostik und Evaluation formuliert, etwa die Orientierung an der Fragestellung, die Kombination globaler und quellenbezogener Maße sowie die zurückhaltende Interpretation von Summenwerten im Einzelfall.

Schlüsselwörter: Lebenssinn · Psychologische Diagnostik · Konstruktvalidität · Fragebogenverfahren · Messinstrumente

ABSTRACT

Empirical research on meaning in life is inseparably linked to the development of suitable measurement instruments. This methodological paper compares three families of instruments that are particularly widely used in research and practice: the Purpose in Life Test, developed within the tradition of logotherapy; the Meaning in Life Questionnaire with its distinction between presence of meaning and search for meaning; and the Sources of Meaning and Meaning in Life Questionnaire (SoMe) and its German counterpart LeBe, which additionally assess sources of meaning. The Existence Scale is considered as an instrument rooted in the existential-analytic tradition. The instruments are described with respect to their theoretical foundations, structure, construct delineation, and typical fields of application. The central focus is on construct validity: the paper discusses to what extent the instruments distinguish experienced meaning from related constructs such as well-being, depressive symptoms, or life satisfaction, and which facets of meaning each of them captures. Finally, recommendations for the selection of instruments in research, assessment, and evaluation are formulated, including orientation toward the research question, the combination of global and source-specific measures, and a cautious interpretation of sum scores in individual assessment.

Keywords: meaning in life · psychological assessment · construct validity · questionnaires · measurement

1 Einleitung

Ein psychologisches Konstrukt ist nur so gut erforschbar, wie es messbar ist. Für den Lebenssinn gilt dies in besonderem Maße, weil der Begriff in Alltagssprache, Philosophie und Psychotherapie mit sehr unterschiedlichen Bedeutungen verwendet wird. Die Wahl eines Messinstruments ist daher nie nur eine technische Entscheidung, sondern impliziert stets eine theoretische Festlegung darüber, was unter Sinn verstanden wird.

Der vorliegende Beitrag stellt ausgewählte, häufig verwendete Verfahren vergleichend dar. Er verfolgt nicht das Ziel einer vollständigen Übersicht, sondern möchte die konzeptuellen Unterschiede zwischen den Instrumenten herausarbeiten und daraus

Empfehlungen für die Praxis ableiten. Leitend ist dabei das Verständnis von Validität als einheitlichem, auf die Interpretation von Testwerten bezogenem Konzept (American Educational Research Association et al., 2014; Messick, 1995).

Hinzu kommt, dass die Forschung zum Lebenssinn in hohem Maße auf Selbstberichtsverfahren beruht. Alternative Zugänge wie qualitative Interviews, narrative Verfahren oder Erhebungen im Alltag mit wiederholten Kurzbefragungen ergänzen das Methodenrepertoire, werden im Folgenden jedoch nur am Rande berücksichtigt.

2 Der Purpose in Life Test

Crumbaugh und Maholick (1964) entwickelten den Purpose in Life Test (PIL), um Frankls Konzept der noogenen Neurose und des existenziellen Vakuums psychometrisch zu erfassen. Das Instrument besteht in seiner bekanntesten Form aus 20 Aussagen, die auf einer siebenstufigen Skala mit jeweils eigenständig formulierten Polen beantwortet werden; ergänzende qualitative Teile mit Satzergänzungen und einem freien Aufsatz werden in der Forschung seltener verwendet. Der PIL war über Jahrzehnte das am häufigsten eingesetzte Sinninstrument und bildet die Grundlage eines großen Teils der logotherapeutisch orientierten Forschung.

Zugleich ist der PIL vielfach kritisiert worden. Dyck (1987) hat in einer frühen Analyse auf konzeptuelle und psychometrische Probleme hingewiesen, insbesondere auf die inhaltliche Heterogenität der Items und auf deren Überschneidung mit Konstrukten wie Depressivität und Lebenszufriedenheit. Einige Items erfassen eher Stimmung oder Lebensfreude als Sinn im engeren Sinne. Diese Kritik betrifft die diskriminante Validität und ist für die Interpretation von Zusammenhängen mit Symptommaßen bedeutsam. Mit der Kurzform PIL-SF haben Schulenberg et al. (2011) eine ökonomische Variante mit vier Items vorgelegt, die stärker auf den Kern des Konstrukts fokussiert.

Ein weiteres Problem liegt in der Formulierung einiger Items, die implizit Wertungen enthalten, etwa im Hinblick auf Lebensziele oder die Einstellung zum Tod. Solche Formulierungen können kulturell und weltanschaulich unterschiedlich verstanden werden. Für die Interpretation von Gruppenunterschieden ist daher Messinvarianz zu prüfen, bevor Mittelwerte zwischen Gruppen verglichen werden.

3 Der Meaning in Life Questionnaire

Steger et al. (2006) entwickelten den Meaning in Life Questionnaire (MLQ) ausdrücklich mit dem Ziel, Schwächen früherer Verfahren zu überwinden. Das Instrument umfasst zehn Items, die zwei Subskalen zugeordnet sind: das Vorhandensein von Sinn und die Suche nach Sinn. Die Autoren legten besonderen Wert auf die Abgrenzung von verwandten Konstrukten und berichteten in ihren Validierungsstudien Hinweise auf konvergente und diskriminante Validität.

Die Stärke des MLQ liegt in seiner Kürze, seiner klaren Struktur und der konzeptuell bedeutsamen Trennung von Vorhandensein und Suche. Eine Grenze besteht darin, dass die Items vergleichsweise global formuliert sind und keine Auskunft darüber geben, woraus eine Person Sinn bezieht oder welche Facette des Sinnerlebens im Vordergrund steht. Die von Martela und Steger (2016) vorgeschlagene Unterscheidung zwischen Kohärenz, Zielorientierung und Bedeutsamkeit wird durch den MLQ nicht differenziert abgebildet.

Für die Interpretation der Suche-Skala ist bedeutsam, dass Sinnsuche nicht per se als Defizit verstanden werden darf. Steger et al. (2006) konzipierten Vorhandensein und Suche als relativ unabhängige Dimensionen. Je nach Lebensphase und Kontext kann Sinnsuche Ausdruck von Offenheit und Entwicklung oder aber von Unsicherheit und Belastung sein. Diagnostisch aussagekräftig wird sie daher erst in Kombination mit dem Ausmaß erlebten Sinns.

4 LeBe und SoMe: Sinnerleben und Sinnquellen

Mit dem Fragebogen zu Lebensbedeutungen und Lebenssinn (LeBe) haben Schnell und Becker (2007) ein Verfahren vorgelegt, das über das globale Sinnerleben hinausgeht. Neben Skalen zur Sinnerfüllung und zur Sinnkrise erfasst das Instrument eine größere Zahl von Lebensbedeutungen, also Quellen, aus denen Menschen Sinn beziehen können. Diese sind übergeordneten Dimensionen zugeordnet, die von vertikaler und horizontaler Selbsttranszendenz über Selbstverwirklichung und Ordnung bis zu Wir- und Wohlgefühl reichen. Die englischsprachige Fassung SoMe wurde von Schnell (2009) beschrieben.

Die besondere Leistung dieses Ansatzes liegt in der Trennung zwischen dem Ausmaß des Sinnerlebens und seinen Quellen. Dadurch werden Fragestellungen zugänglich, die mit globalen Maßen nicht untersucht werden können, etwa ob Sinnerleben eher von der

Vielfalt oder von der Intensität einzelner Sinnquellen abhängt. Zudem erlaubt die getrennte Erfassung von Sinnerfüllung und Sinnkrise die Identifikation von Personen, die weder Sinn erleben noch an dessen Fehlen leiden (Schnell, 2020). Der größere Umfang des Instruments ist bei der Planung von Studien und diagnostischen Untersuchungen allerdings zu berücksichtigen.

Für die Praxis ist hervorzuheben, dass das quellenbezogene Profil Anknüpfungspunkte für Beratung und Therapie bieten kann, etwa wenn sichtbar wird, dass das Sinnerleben einer Person auf sehr wenigen Quellen beruht. Solche Profile sollten allerdings nicht normativ gelesen werden: Es gibt keine für alle Menschen gleichermaßen richtige Zusammensetzung von Sinnquellen.

5 Die Existenzskala

Aus der Tradition der Existenzanalyse stammt die Existenzskala (ESK) von Längle et al. (2000). Sie erfasst nicht primär das Erleben von Sinn, sondern personale Fähigkeiten, die nach existenzanalytischem Verständnis Voraussetzungen sinnvoller Lebensgestaltung sind: Selbstdistanzierung, Selbsttranszendenz, Freiheit und Verantwortung. Damit operationalisiert sie zentrale Konzepte der Frankl'schen Anthropologie und eignet sich insbesondere für Fragestellungen, die auf existenzielle Ressourcen und deren Veränderung im therapeutischen Prozess zielen.

Für Evaluationsstudien logotherapeutischer und existenzanalytischer Interventionen ist die Existenzskala von besonderem Interesse, weil sie Fähigkeiten erfasst, die nach der zugrunde liegenden Theorie durch die Behandlung gefördert werden sollen. Damit eignet sie sich potenziell als Prozessmaß. Zugleich ist zu beachten, dass die Skala eng an ein bestimmtes theoretisches Modell gebunden ist; ihre Ergebnisse sind daher vor allem im Rahmen dieses Modells interpretierbar (Längle et al., 2000).

6 Konstruktvalidität als Leitfrage

Bereits Cronbach und Meehl (1955) haben betont, dass Konstruktvalidität nicht durch einen einzelnen Koeffizienten belegt, sondern nur im Rahmen eines nomologischen Netzwerks plausibilisiert werden kann. Für die Messung von Lebenssinn bedeutet dies, dass Instrumente nicht nur mit Wohlbefinden und psychischer Gesundheit zusammenhängen, sondern sich zugleich von diesen Konstrukten unterscheiden sollten. Ein Instrument, das Sinnerleben weitgehend als Gegenteil depressiver Verstimmung erfasst, ist für die Prüfung der Hypothese, Sinn wirke als eigenständiger Schutzfaktor, kaum geeignet.

Auch die Abgrenzung zum eudaimonischen Wohlbefinden ist bedeutsam. Ryff (1989) hat Lebenszweck als eine von mehreren Dimensionen psychologischen Wohlbefindens konzipiert. Wer Sinnerleben und Wohlbefinden gleichzeitig erhebt, sollte daher prüfen, ob die verwendeten Instrumente inhaltlich überlappende Items enthalten. Andernfalls können Zusammenhänge teilweise auf Itemüberschneidung statt auf substanzielle Beziehungen zurückgehen.

Eine weitere Herausforderung betrifft die Unterscheidung zwischen Zustands- und Merkmalsaspekten. Sinnerleben kann über die Zeit hinweg relativ stabil sein, unterliegt aber auch situativen Schwankungen, wie Untersuchungen zum Zusammenhang mit positivem Affekt nahelegen (King et al., 2006). Für Veränderungsmessungen in Therapie und Beratung ist daher zu prüfen, ob ein Instrument hinreichend änderungssensitiv ist; für die Interpretation individueller Veränderungen sind Kennwerte wie der Standardmessfehler heranzuziehen.

7 Empfehlungen für die Instrumentenwahl

Aus dem Vergleich lassen sich einige Empfehlungen ableiten. Erstens sollte die Wahl eines Instruments von der Fragestellung ausgehen: Für ökonomische Erhebungen des globalen Sinnerlebens bietet sich der MLQ an, für die Untersuchung von Sinnquellen und Sinnkrisen der LeBe bzw. SoMe, für die Erfassung existenzieller Fähigkeiten die Existenzskala. Der PIL bleibt für die Vergleichbarkeit mit der älteren Forschung bedeutsam, sollte aber in Kenntnis seiner Überschneidungen mit verwandten Konstrukten interpretiert werden.

Zweitens erscheint in vielen Fällen die Kombination eines globalen mit einem quellen- oder facettenbezogenen Maß sinnvoll. Drittens ist bei der Einzelfalldiagnostik Zurückhaltung geboten: Fragebogenwerte zum Lebenssinn können ein klinisches Gespräch über Werte, Ziele und Lebensumstände ergänzen, aber nicht ersetzen. Schließlich ist bei der Verwendung übersetzter Instrumente auf geprüfte Sprachfassungen und die Angemessenheit der Normierung für die jeweilige Zielgruppe zu achten.

Schließlich sollte bei der Berichterstattung angegeben werden, welche Version eines Instruments, welche Antwortskala und welche Auswertungsregeln verwendet wurden. Gerade beim PIL existieren

unterschiedliche Fassungen und Übersetzungen, was die Vergleichbarkeit von Befunden erschwert. Transparente Angaben erleichtern Replikationen und meta-analytische Integrationen und entsprechen den Anforderungen an eine nachvollziehbare Testanwendung (American Educational Research Association et al., 2014).

Literatur

American Educational Research Association, American Psychological Association, & National Council on Measurement in Education. (2014). Standards for educational and psychological testing. American Educational Research Association.

Cronbach, L. J., & Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests. Psychological Bulletin, 52(4), 281–302.

Crumbaugh, J. C., & Maholick, L. T. (1964). An experimental study in existentialism: The psychometric approach to Frankl's concept of noogenic neurosis. Journal of Clinical Psychology, 20(2), 200–207.

Dyck, M. J. (1987). Assessing logotherapeutic constructs: Conceptual and psychometric status of the Purpose in Life and Seeking of Noetic Goals tests. Clinical Psychology Review, 7(4), 439–447.

King, L. A., Hicks, J. A., Krull, J. L., & Del Gaiso, A. K. (2006). Positive affect and the experience of meaning in life. Journal of Personality and Social Psychology, 90(1), 179–196.

Längle, A., Orgler, C., & Kundi, M. (2000). Existenzskala (ESK). Beltz Test.

Martela, F., & Steger, M. F. (2016). The three meanings of meaning in life: Distinguishing coherence, purpose, and significance. The Journal of Positive Psychology, 11(5), 531–545.

Messick, S. (1995). Validity of psychological assessment: Validation of inferences from persons' responses and performances as scientific inquiry into score meaning. American Psychologist, 50(9), 741–749.

Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069–1081.

Schnell, T. (2009). The Sources of Meaning and Meaning in Life Questionnaire (SoMe): Relations to demographics and well-being. The Journal of Positive Psychology, 4(6), 483–499.

Schnell, T. (2020). Psychologie des Lebenssinns (2. Aufl.). Springer.

Schnell, T., & Becker, P. (2007). Fragebogen zu Lebensbedeutungen und Lebenssinn (LeBe). Hogrefe.

Schulenberg, S. E., Schnetzer, L. W., & Buchanan, E. M. (2011). The Purpose in Life Test-Short Form: Development and psychometric support. Journal of Happiness Studies, 12(5), 861–876.

Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53(1), 80–93.

ZITIERVORSCHLAG (ORIGINALFASSUNG)

Ashford, S. R., Pazer, S., & Whitcombe, E. M. (2026). Measuring Meaning in Life: The Purpose in Life Test, the Meaning in Life Questionnaire, and LeBe/SoMe in Conceptual and Methodological Comparison. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(1), 14–17.

LIZENZ, KORRESPONDENZ UND EINSATZ VON KI

Erscheint im offenen Zugang unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Korrespondenz: Redaktion der Zeitschrift. Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung generativer KI verfasst und von den Autorinnen und Autoren geprüft, die die volle Verantwortung für den Inhalt tragen.